

CHIRURGIE
TRAUMATOLOGIQUE
ET
ORTHOPÉDIQUE

EXERCICE

1. QUESTIONS A CHOIX DOUBLE (QCD)

CHOISIR A=VRAI B=FAUX

1. Le polytraumatisé est tout malade ayant au moins deux traumatismes
2. La soudaine inefficacité de la pompe cardiaque qui entraîne une chute brutale du débit cardiaque définit le choc cardiogénique
3. L'état de choc est un syndrome général de plus ou moins grande gravité, observé après toute agression de l'organisme quelle que soit sa nature
4. L'état de dépendance du patient fait partie du rôle de l'infirmier en préopératoire dans les traumatismes des ménisques
5. L'impotence fonctionnelle relative ou absolue est un signe fonctionnel du traumatisme du bassin
6. La précipitation est un geste salvateur dans la CAT auprès d'un traumatisé des voies publiques
7. L'existence de lésions de l'abdomen est un élément de l'examen du traumatisé conscient des voies publiques
8. La luxation incomplète est une subluxation
9. La fracture de Pouteau-Colles se traduit par une déformation en dos de fourchette sur la radiographie de profil du poignet
10. L'hypoesthésie du muscle deltoïde consécutive à une fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus, fait évoquer une lésion du nerf axillaire
11. Dans le traitement des fractures des 2 os de l'avant-bras, il faut sauvegarder les mouvements de pronosupination
12. Les fractures ouvertes de jambe, sont des fractures exposées du tibia et ou de la fibula qui intéressent les surfaces articulaires
13. Une fracture de la jambe qui se consolide avec un chevauchement de plus de 2 cm donne un retentissement fonctionnel
14. Selon Cauchoix et Duparc le type II des lésions cutanées correspond aux plaies ponctiformes à bords nets, pouvant être suturées sans tension
15. La luxation antéro-interne de l'épaule peut entraîner les lésions des vaisseaux axillaires et du plexus brachial

16. Le syndrome de wolkman est causé par un plâtre trop serré avec un coude trop fléchi
17. L'hématome de la cuisse consécutif à une fracture du fémur peut être de 500CC et entraîner un choc hypovolémique
18. L'ostéomyélite aiguë est due à un choc traumatique
19. La fracture de Pouteau-Colles se traduit par le signe de Laugier à la radiographie
20. L'ostéomyélite aiguë s'accompagne de lymphangite aiguë
21. Le diagnostic clinique de l'ostéomyélite doit être suivi de perfusion d'antibiotique dans le quart d'heure et d'un plâtre dans les deux heures

II. QUESTIONS A CHOIX MULTIPLE (QCM)

CHOISIR LA /LES REPONSE(S) JUSTE(S)

22. Le traitement de la fracture de la rotule a pour but :
 - A- Immobilisation (genouillère plâtrée en extension)
 - B- Réduction anatomique
 - C- Contention solide
 - D- Chirurgie par ostéosynthèse
 - E- Récupération de la formation du genou
23. Les signes généraux du mal de Pott sont :
 - A- Raideur marquée du rachis
 - B- Asthénie
 - C- Fièvre vespérale
 - D- Gibbosité
 - E- Altération de l'état général
 - F- Contracture des muscles paravertébraux
24. Le diagnostic différentiel de la luxation antéro-interne de l'épaule se fait avec les lésions suivantes :
 - A- Fracture du col de l'omoplate
 - B- Fracture du col de l'humérus
 - C- Fracture de la grosse tubérosité
25. Sur les lieux de l'accident le rôle de l'infirmier en cas de suspicion de fracture consiste à :
 - A- Préparer le champ opératoire
 - B- Faire une immobilisation provisoire
 - C- Faire un pansement aseptique

26. Les symptômes cités ci-dessous évoquent le syndrome de Wolkman :

- A- Œdème
- B- Hémarthrose
- C- Hématome
- D- Douleur +/- vive de l'avant-bras ou la main
- E- Impotence fonctionnelle

27. Le nursing du malade consiste à :

- A- Faire le prélèvement pour le bilan préopératoire
- B- Faire la toilette et la prévention des escarres
- C- Faire la préparation physique pour une éventuelle opération

28. Un patient présentant plusieurs fractures sur toutes les parties de son membre supérieur droit ne mettant pas en jeu le pronostic vital. Ce patient est selon vous :

- A- Un polytraumatisé
- B- Un polytraumatisé et un polyfracturé
- C- Un polyfracturé

29. Ces différents types de chocs font suite au traumatisme violent, lesquels :

- A- Choc opératoire
- B- Choc hypovolémique
- C- Choc traumatique

30. Les complications secondaires des traumatismes du bassin sont :

- A- Ouverture cutanée
- B- Thromboembolie
- C- Lésion du rectum
- D- Infection
- E- Lésion de l'urètre

31. Le traitement d'une fracture déplacée comporte deux temps principaux :

- A- La contention
- B- La rééducation
- C- La réduction
- D- L'ostéosynthèse
- E- La traction-suspension

32. La fracture du corps du radius et du cubitus sans déplacement se traite par :

- A- La réduction manuelle
- B- La réduction

- C- L'application d'un plâtre le long du bras
 - D- Réduction chirurgicale
 - E- Mise en place d'une plaque de compression avec des vis
33. L'évolution favorable en cas fracture de Pouteau-Colles se fait vers la consolidation en :
- A- Deux mois et demi à trois mois
 - B- Trois mois à quatre mois
 - C- Quatre à cinq semaines sous réserve d'un traitement
34. Les luxations antéro interne de l'épaule se caractérisent par les signes :
- A- La vacuité de la glène
 - B- Comblement du sillon delto pectoral
 - C- Le signe de l'épaulette
 - D- Le bras en adduction
35. Concernant les fractures diaphysaires du fémur, relever la plus fréquente des complications immédiates
- A- Embolie graisseuse
 - B- Hématome
 - C- Embolie pulmonaire
36. Qu'est-ce qui différencie le polytraumatisé du poly fracturé ?
- A- La présence d'au moins deux lésions pouvant engager le pronostic vital du patient
 - B- La présence des signes pouvant engager le pronostic fonctionnel du membre chez le polytraumatisé
 - C- Les fractures multiples chez le patient
37. Concernant l'ostéomyélite aiguë :
- A- Le germe le plus souvent concerné est le staphylocoque doré
 - B- Il y a des facteurs favorisants (changement de saisons, mauvais équilibre biologique)
 - C- Se développe près du genou et loin du coude
 - D- Réalise un tableau douloureux non fébrile